

Инструкция по применению
Средство внутриматочное
противозачаточное «Юнона Био-Т»
кольцеобразной формы №1,
средство внутриматочное
противозачаточное «Юнона Био-Т»
кольцеобразной формы №2,
средство внутриматочное
противозачаточное «Юнона Био-Т Ag»
кольцеобразной формы № 1,
средство внутриматочное
противозачаточное «Юнона Био-Т Ag»
кольцеобразной формы № 2

Инструкция для врача

Область применения – гинекология, средство внутриматочной контрацепции. Установка и удаление средства внутриматочного противозачаточного (далее ВМС) производится подготовленным медицинским специалистом (акушер-гинеколог) в условиях медучреждения.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 3.

Принцип действия:

Механизм действия ВМС состоит в иницировании химических изменений, инактивирующих сперматозоиды и яйцеклетку до момента их слияния, а также в иницировании изменений, препятствующих имплантации.

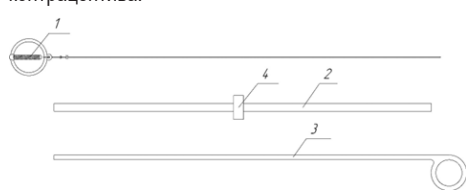
Контрацептивный эффект развивается сразу после установки ВМС в полость матки.

Восстановление фертильности происходит сразу после удаления ВМС из полости матки.

Описание

Якоря средства внутриматочных противозачаточных «Юнона Био-Т» кольцеобразной формы № 1, № 2, «Юнона Био-Т Ag» кольцеобразной формы № 1, № 2 изготовлены из полимерного материала с заданными механическими характеристиками и имеют форму замкнутого кольца. Диаметр кольца ВМС «Юнона Био-Т» № 1, «Юнона Био-Т Ag» № 1 – 18 ± 3 мм, «Юнона Био-Т» № 2, «Юнона Био-Т Ag» № 2 – 23 ± 3 мм. В плоскости кольца размещен внутренний стержень, на который намотана медная («Юнона Био-Т» № 1, № 2) или медная с серебряным сердечником («Юнона Био-Т Ag» № 1, № 2) проволока. На якоре имеется петля для крепления монофиламентной трансцервикальной нити длиной не менее 100 мм. Степень чистоты меди в медной проволоке, меди и серебра в биметаллической проволоке не менее 99,9 %. Содержание серебра в биметаллической медной с серебряным сердечником проволоке ВМС «Юнона Био-Т Ag» не менее 9,3 %. Номинальная площадь медьсодержащей поверхности ВМС «Юнона Био-Т» № 2, «Юнона Био-Т Ag» № 2 – 380 мм², для ВМС «Юнона Био-Т» № 1, «Юнона Био-Т Ag» № 1 – 255 мм².

ВМС поставляется в стерилизационной (индивидуальной) упаковке в виде бумажно-пленочного пакета в комплекте с полимерной вводной трубкой (диаметр не более 5 мм) и поршнем. На вводной трубке установлен передвижной полимерный ограничитель для обозначения глубины введения и плоскости якоря контрацептива.



1 – ВМС; 2 – Вводная трубка;
3 – Поршень; 4 – Ограничитель.

Обобщенные результаты клинических исследований, проведенных в целях регистрации, перерегистрации и постмаркетингового наблюдения, могут быть получены у производителя по запросу.

Максимальный срок использования:

ВМС «Юнона Био-Т» кольцеобразной формы № 1 – не более 3 лет;
ВМС «Юнона Био-Т» кольцеобразной формы № 2 – не более 5 лет;
ВМС «Юнона Био-Т Ag» кольцеобразной формы № 1 – не более 5 лет;
ВМС «Юнона Био-Т Ag» кольцеобразной формы № 2 – не более 7 лет.

Предостережения

Изделие поставляется стерильным и готовым к использованию.

Стерилизация газовая – оксидом этилена.

Срок годности ВМС в упаковке - 5 лет. Недопустимо применение ВМС при превышении срока годности, указанного на этикетке. Срок годности определяется сохранением стерильности ВМС в конечной упаковке.

Недопустимо повторное использование изделий. Недопустимо применение ВМС при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки. При нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки использовать изделие запрещено, и изделие подлежит утилизации.

Изделие должно храниться при температуре от +5 °С до +40 °С, в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

Применять ВМС необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Использованные изделия подлежат утилизации согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям по обращению с отработанными медицинскими изделиями.

ВМС техническому, сервисному обслуживанию и ремонту не подлежат.

ВМС должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Средства внутриматочной контрацепции не защищают от инфекций, передаваемых половым путем, и вируса иммунодефицита человека (ИППП/ВИЧ).

Показания к применению ВМС

Желание женщины предохранить себя от беременности.

Лечение и профилактика синдрома Ашермана.

В качестве посткоитального средства ВМС может вводиться в течение 5 дней (120 часов) после незащищенного полового акта.

Противопоказания к применению ВМС

Внутриматочная контрацепция абсолютно противопоказана (категории 3 и 4 согласно критериям приемлемости методов контрацепции ВОЗ):

- при беременности (подозреваемой или подтвержденной);
- при злокачественных заболеваниях женских половых органов;
- при фоновых/предраковых заболеваниях шейки матки в настоящий момент;
- при тяжелой тромбоцитопении;
- при вагинальных кровотечениях неустановленной этиологии (подозрение на серьезное заболевание);
- при гестационной трофобластической болезни;
- при миоме матки с деформацией полости матки;
- при любых врожденных или приобретенных аномалиях полости матки, приводящих к деформации ее полости, несовместимых с установкой ВМС;
- при ВЗОМТ в настоящий момент;
- при ИППП (гнойный цервицит, хламидийная инфекция или гонорея в настоящее время), повышенном риске ИППП;
- при СПИД (на фоне антиретровирусной терапии);
- при туберкулезе тазовой локализации;
- при аллергии на медь, серебро и медь (для серебросодержащих моделей ВМС);
- при болезни Вильсона.

Побочное действие

- Увеличение менструальной кровопотери. На фоне использования ВМС может наблюдаться увеличение длительности менструальных выделений на 1-2 дня и увеличение объема менструальной кровопотери на 50-55 %. У пациенток со склонностью к железодефицитной анемии требуется контролировать лабораторные показатели для своевременной диагностики и коррекции данного состояния.

- Пред- и межменструальные кровянистые выделения. При стойких нарушениях менструального цикла необходимо исключить частичную экспульсию ВМС или другие состояния, требующие удаления контрацептива. При отсутствии показаний к удалению контрацептива возможна медикаментозная терапия (препараты группы НПВС).

Осложнения

- Болевой синдром при введении/удалении ВМС. Данное состояние наблюдается редко. У пациенток с низким болевым порогом целесообразно использование средств местной анестезии.

- Перфорация матки при введении ВМС. Случаи перфорации матки при установке ВМС редки (менее 1 на 3000 установок). Следует соблюдать предельную осторожность, если имеется крайнее заднее положение матки. При подозрении на перфорацию необходимо уточнить локализацию ВМС. Контрацептив должен быть удален. Возможно, потребуется хирургическое вмешательство.

- Развитие ВЗОМТ. В настоящее время считается, что развитие ВЗОМТ в первые несколько месяцев после введения ВМС может быть связано с контаминацией полости матки при установке контрацептива эндогенной флорой и цервикальной микрофлорой. Причиной развития ВЗОМТ спустя 3-4 месяца после установки контрацептива являются ИППП, а не сама процедура установки контрацептива. Для снижения рисков необходимо исключить инфекционные противопоказания к использованию средств внутриматочной контрацепции и тщательное соблюдение асептики и антисептики при процедуре установки ВМС. Возможно применение антибиотикопрофилактики при введении контрацептива.

Информация о выявлении нежелательных событий, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента), а также информация о побочных эффектах и осложнениях, не указанных в инструкции по применению, должна быть сообщена производителю.

Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействия с лекарственными средствами не выявлено. При необходимости диагностического (МРТ) и терапевтического облучения медицинский персонал должен быть информирован о наличии ВМС.

В некоторых случаях может потребоваться удаление контрацептива.

Показания для удаления ВМС

Восстановление фертильности после удаления ВМС происходит сразу.

ВМС должно быть удалено:

- при желании женщины в любой день менструального цикла;
- обязательно удаление ВМС после окончания срока использования;
- при отсутствии уверенности в правильном расположении ВМС непосредственно после введения необходимо извлечь контрацептив и ввести новое противозачаточное средство;
- контрацептив должен быть удален при развитии воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ);
- при развитии стойких нарушений менструального цикла на фоне ВМС, появлении вагинальных кровотечений неустановленной этиологии (подозрение на серьезное заболевание);
- при развитии анемии;
- при частичной экспульсии ВМС;
- при болевом синдроме, связанном с наличием ВМС в полости матки;
- при развитии беременности на фоне ВМС.

В данной ситуации в большинстве случаев диагностируется маточная беременность, однако необходимо исключить внематочную беременность. Женщины, которые забеременели во время использования ВМС, должны быть проинформированы о повышенном риске септического самопроизвольного аборта, повышенном риске преждевременных родов и инфекции, если ВМС останется в матке. Женщины, желающие сохранить беременность, должны быть проинформированы о том, что удаление ВМС (при наличии условий для этой процедуры) снизит возможные риски неблагоприятного течения беременности. Однако сама процедура удаления ВМС повышает риск выкидыша. Частота незапланированной беременности при использовании ВМС составляет менее 1 случая на 100 женщин, использующих данный метод, в течение первого года (6-8 случаев на 1000 женщин). Незначительный риск незапланированной беременности сохраняется на протяжении всего периода использования ВМС (около 2 случаев на 100 женщин за 5-6 лет использования).

Рекомендуемые сроки введения ВМС:

- любой день менструального цикла (предпочтительней с 4 по 19 день);
- непосредственно после неосложненного медицинского аборта, произведенного методом вакуум-аспирации или кюретажа;
- по окончании инволюции матки (через 5-6 недель после неосложненных родов), в т.ч. на фоне лактационной аменореи;
- сразу после извлечения ВМС, срок использования которого истек, при желании женщины продолжить внутриматочную контрацепцию и отсутствии противопоказаний к использованию ВМС;
- с целью посткоитальной контрацепции ВМС вводится в течение 5 дней (120 часов) после незащищенного полового акта.

Адаптация к ВМС

В период адаптации организма пациентки к ВМС (3-4 месяца) возможны изменения менструального цикла. Менструальные выделения могут сопровождаться тянущей болью внизу живота или крестцовой области, которая, как правило, быстро затихает.

С целью повышения приемлемости ВМС и сокращения периода адаптации рекомендуется:

- проведение тщательного обследования женщин для выявления противопоказаний к применению ВМС;
- дифференцированный подход к выбору модели ВМС, исходя из индивидуальных особенностей организма женщины, планов на деторождение, времени введения ВМС;
- использование рекомендуемой техники введения внутриматочного средства и оптимальных сроков для его установки;
- назначение препаратов группы НПВС в первые дни после введения ВМС и в течение трех первых менструальных выделений.

Обследование пациентки перед введением ВМС

Пациентка должна быть ознакомлена с достоинствами, недостатками и возможными осложнениями метода внутриматочной контрацепции. Объем обследования перед введением ВМС должен позволять исключить возможные противопоказания к применению метода внутриматочной контрацепции.

Обследование пациентки перед введением ВМС (объем обследования пациентки перед введением ВМС регламентируется национальными медицинскими протоколами и в разных странах может различаться):

- клиническое обследование;
- бактериоскопический анализ влагалищных мазков;
- Рар-мазок (мазок для онкоцитологического исследования).

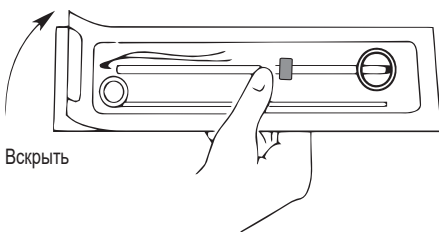
Процедура введения ВМС

Процедура введения ВМС выполняется врачом акушером-гинекологом, владеющим соответствующей техникой, с соблюдением общепринятых правил асептики и антисептики.

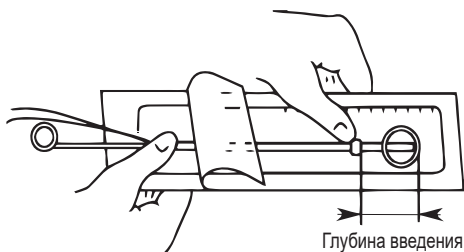
После гинекологического осмотра и исключения противопоказаний к применению метода внутриматочной контрацепции в асептических условиях вводят зеркала и трехкратно обрабатывают шейку матки и влагалище раствором антисептика. Затем фиксируют шейку матки пулевыми щипцами и несколько низводят, стерильным зондом определяют направление оси цервикального канала и длину полости матки. В некоторых случаях может потребоваться инструментальное расширение цервикального канала расширителями Гегара до № 4-5.

Подготовка ВМС к введению

1. Вскройте упаковку со стороны трансцервикальной нити.



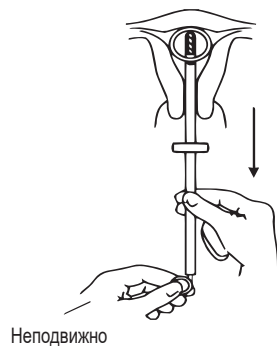
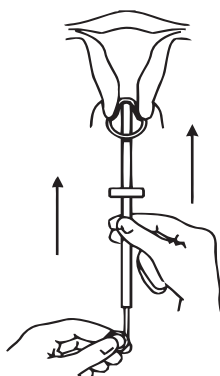
2. Установите подвижный ограничитель на расстояние, соответствующее длине полости матки по зонду. Введите поршень в трубку до соприкосновения с якорем ВМС. Для контроля расположения якоря ВМС поверните ограничитель на вводной трубке до совмещения плоских поверхностей ограничителя с предполагаемой плоскостью якоря ВМС.



Процедура введения ВМС (метод «изъятия»)

1. Сохраняя тракцию за пулевые щипцы, как при зондировании полости матки, не прилагая чрезмерных усилий, введите ВМС через канал шейки матки до ограничителя. Движение осуществляйте вводной трубкой и поршнем одновременно.

Внимание: поршень должен оставаться неподвижным, поддерживая якорь ВМС.



Неподвижно

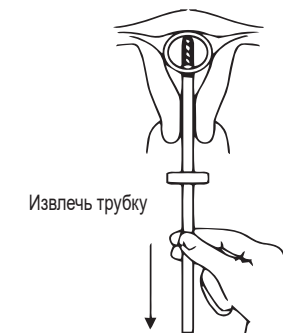
2. Извлеките поршень.



Извлечь поршень

Неподвижно

3. Извлеките вводную трубку.



Извлечь трубку

4. Обрежьте концы трансцервикальной нити так, чтобы они выступали из шейки матки на 2-3 см.

Удаление ВМС из полости матки

Для удаления ВМС следует захватить трансцервикальную нить зажимом и тракцией на себя удалить якорь ВМС из полости матки. В случае обрыва, «потери» нити или невозможности ее фиксации может потребоваться инструментальное удаление ВМС.

Производитель:

ЗАО «Медицинское предприятие Симург»
Республика Беларусь, 210023, г. Витебск,
пр-т Генерала Людникова, 13, комната 413,
тел.: +375 (212) 62-32-33



Юнона

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 10.09.2024